

Tutti attorno a una persona autistica in cura ad alto supporto

La guida cumulativa per l'intera équipe attorno a una persona autistica in assistenza / residenziale / cura ad alto supporto (qualsiasi età) — famiglia e parenti, medici e clinici della RSA, assistenti e assistenti personali, e personale infermieristico/residenziale. Una scheda di riferimento estesa; abbinatela alle guide rapide per singolo interlocutore.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di una persona si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Per una persona autistica ad alto supporto, gli ambienti di cura sono spesso i **più difficili in assoluto**: ostili sul piano sensoriale, dirompenti per la routine, pieni di contatto e richieste imprevedibili. Molti comunicano senza parlare (CAA, comportamento, una persona di fiducia) e potrebbero non registrare o segnalare dolore se non quando è grave. Il principio condiviso per tutta l'équipe è radicale e semplice: **leggere ogni comportamento come comunicazione di un bisogno non soddisfatto** — dolore, paura, sovraccarico o una routine perduta — e proteggere prevedibilità, oggetti, interessi e agency. Dignità e consenso dipendono dal lavorare *con* la persona, non dal dare per scontata l'incapacità.

Cosa aiuta in ogni contesto

- **Indagate prima il dolore e le cause fisiche** per ogni nuovo malessere — stitichezza, dolore dentale, infezioni, attrezzature mal calibrate sono colpevoli comuni e nascosti.
- **Costruite le cure attorno alla prevedibilità** — personale costante, stessa sequenza, agende visive, preavviso di ogni cambio.
- **Riducete il carico sensoriale** — stanza quiete, luce soffusa, meno bip e odori forti; conservate gli oggetti, gli interessi e le routine della persona.
- **Usate il decision-making supportato** — spiegate in forma accessibile e letterale; concedete tempo di elaborazione; consultate l'accompagnatore di fiducia ed eventuale profilo comunicativo/anticipato.
- **Avere un piano calmo e scritto per meltdown/shutdown**: riducete gli stimoli, assicurate la sicurezza, date tempo e spazio — non contenete e non punite.
- **Documentate e condividete un profilo individualizzato sensoriale, comunicativo e di reasonable adjustments** con tutta l'équipe.
- **Mantenete l'équipe coordinata e coerente** — un profilo condiviso e un unico insieme di approcci concordati tra famiglia, clinici, assistenti e infermieristica previene il malessere che i cambi di personale e i fili che si incrociano causano.
- **Pianificate ogni transizione e ricovero in anticipo** — un „passaporto sanitario” scritto, foto del nuovo ambiente e un contatto noto trasformano i momenti più difficili (ospedale, trasloco, cambio di personale) in momenti gestibili.

- **Tenete disponibili e funzionanti gli ausili comunicativi e la CAA** — per molti, la CAA è la loro voce; un dispositivo mancante o scarico è un'emergenza, non un inconveniente.

Cosa evitare in ogni contesto

- Etichettare il malessere come „comportamentale” prima di aver escluso dolore e sovraccarico.
- Usare la contenzione o la sedazione come prima risposta a meltdown/shutdown.
- Rimuovere routine, oggetti o interessi „per il loro bene”.
- Presumere l'incapacità dalla comunicazione atipica o non verbale.
- Lasciare che ausili comunicativi, oggetti o routine si „perdano” ai passaggi di consegne o ai ricoveri — la continuità è sicurezza; documentatela e tramandatela.

Note rapide per ciascuno attorno alla persona

Famiglia e parenti

Siete la loro memoria, l'avvocato e la continuità. Condividete e aggiornate un profilo di una pagina (interessi, routine, bisogni sensoriali, segnali precoci di allarme, cosa li regola). Insistete che il dolore sia escluso prima per ogni nuovo malessere; proteggete routine, oggetti e interessi; spingete per il decision-making supportato e un passaporto sanitario; visitateli e connettetevi attraverso il loro interesse.

Medici e clinici della RSA

Trattate il malessere nuovo o crescente come una **red flag medica** finché dolore, infezione, stitichezza, problemi dentali e cause sensoriali/ambientali non sono esclusi. Cercate il burnout autistico sotto carico cronico. Usate il decision-making supportato e un passaporto sanitario; documentate gli adattamenti efficaci.

Assistenti e assistenti personali (personale residenziale)

Voi siete l'ambiente quotidiano. Personale e sequenza costanti, agende visive, oggetti e interessi conservati, un piano calmo per meltdown/shutdown (riducete gli stimoli, assicurate la sicurezza, nessuna contenzione). Documentate e condividete un profilo individualizzato; fate pressione con famiglia e clinici.

Personale infermieristico e residenziale

Prima il dolore e le cause fisiche; prevedibilità e routine conservate; ridotto carico sensoriale; decision-making supportato; un piano calmo e scritto per meltdown/shutdown; un passaporto sanitario per ogni ricovero. Leggete ogni comportamento come comunicazione di un bisogno non soddisfatto.

Quando chiedere altro supporto

Trattate il **malessere nuovo o crescente** come una red flag medica finché dolore, infezione, stitichezza, problemi dentali e cause sensoriali/ambientali non sono esclusi. Cercate il **burnout autistico** sotto carico cronico. Coinvolgete i **team specialistici autismo / disabilità intellettiva** e logopedia (CAA). Pianificate ogni ricovero con un „passaporto ospedaliero/sanitario” e un piano meltdown/shutdown concordato che priorizzi la sicurezza sulla contenzione.

Nota di genere

Le donne ad alto supporto sono particolarmente sotto-individuate e poco seguite; il loro malessere è ancora più spesso frainteso. Applicate lo stesso rigore nell'escludere dolore e sovraccarico in tutta l'équipe, a prescindere dalla presentazione o dal metodo di comunicazione.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parte 5, RSA e ospedali), la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parti 3.5 e 4) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela alla singola persona; la famiglia la conosce meglio.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, interocezione/dolore); Autism Society (2025, meltdown/shutdown); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space); AASPIRE AHAT. Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.